











UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
HUMAN SCIENCES, CURRICULUM EDUCATION

CICLO XXIX

Leggere la Qualità della Vita dell'adulto con disabilità fisica: dall'osservazione dell'ambiente di vita alla rilevazione delle percezioni.

Nella Struttura residenziale della Comunità di Capodarco di Fermo.

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa Catia Giaconi

DOTTORANDA

Dott.ssa Michela Carbonari

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Michele Corsi

ANNO 2017

Tab. 1

I quadri teorici della QdV

Autori	Dimensioni della Qualità della Vita
Schalock, Keith e Hoffman (1990)	Soddisfazione, produttività, *empowerment* e appartenenza sociale;
World Health Organization (WHO, 1995)	Condizioni fisiche, condizioni psicologiche, ambiente, relazioni sociali, livello di indipendenza, credenze spirituali/personali/religiose;
Felce e Perry (1995)	benessere fisico, benessere emotivo, benessere materiale, benessere sociale, benessere produttivo;
Cummins (1997)	salute, benessere emotivo, benessere materiale, intimità, posizione nella comunità, sicurezza e produttività;
Schalock e Verdugo (2002)	benessere fisico, benessere emotivo, benessere materiale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, sviluppo personale, autodeterminazione e diritti.

Fonte: Adatt. Conner (2015)

I cinque quadri concettuali di Schalock, Keith e Hoffman (1990), della WHO (1995), di Felce e Perry (1995), di Cummins (1997) e di Schalock e Verdugo (2002) sono ampiamente riconosciuti dal consenso internazionale, essendo i riferimenti teorici principali alla base delle ricerche e degli strumenti di valutazione della QdV, si veda p. 26. Questa visione congiunta di più prospettive testimonia quanto, negli ultimi trent'anni, la ricerca sul costrutto di QdV sia stata tesa ad approdare della multidimensionalità del costrutto di QdV (Verdugo et al., 2012).

1.3 I sette principi e gli scopi

Alla luce ricostruzione storica del paradigma e della disamina dei maggiori contribuiti scientifici, abbiamo estrapolato i principi alla base della concezione odierna del paradigma della Qualità della Vita (Fig.1).

Il primo risulta essere la multidimensionalità (*domains theory*). Come abbiamo visto è stata superata la dicotomia degli approcci unidimensionali e quelli multidimensionali, a favore di quelli multidimensionali. Gli studiosi sono concordi,

ad oggi, alla presa in esame congiunta di dimensioni pluralistiche tese ad indagare non solo gli aspetti prettamente materiali della vita, ma anche le aree sommerse ad una rilevazione statistica ed economica, quali le condizioni psicofisiche, relazionali, contestuali.

A questo principio si aggancia il secondo inerente la visione olistica del costrutto della Qualità della Vita (Schalock, Verdugo, 2002, 2010).Gli autori convengono sulla stretta interconnessione esistente tra i vari aspetti o dimensioni di vita della persona, ciò significa che essi si influenzano reciprocamente (*olistic approach*). La QdV di una persona non può essere spiegata, considerata o misurata mediante una visione approssimativa di una sola dimensione (ad esempio il benessere fisico) e senza assumere la consapevolezza che ogni nuovo elemento (ad esempio l'introduzione di una nuova attività) che si inserisce nella vita della persona abbia effetti, non solo sulla dimensione che si vuole potenziare (ad esempio il benessere fisico) ma anche sulle altre (ad esempio il benessere emotivo, l'inclusione ecc.) in modo trasversale[7].

Il terzo principio è la necessità di cogliere sia gli elementi soggetti sia gli elementi oggettivi che connotano e determinano la Qualità della Vita, come abbiamo visto[8](*subjective and objective elements*). L'ambiente di vita, le attività ricreative, la comunità di appartenenza, il reddito ecc. ci danno informazioni importanti sulla QdV di una persona, ma da sole non sono in grado di spiegare la percezione personale, ovvero il grado di soddisfazione e di benessere della persona. Allo stesso tempo,

---

[7] Facciamo un esempio, se il professionista intenzionato a sviluppare nella persona con disabilità l'aspetto dell'inclusione sociale predispone una serie di interventi atti a far partecipare la persona, appassionata al teatro, ad un corso di recitazione, ciò avrà effetti non solo sul dominio inclusione sociale, ma a cascata su tutti gli altri: autodeterminazione, benessere emotivo, relazioni interpersonale ecc.

[8] L'assunzione di una delle due prospettive di analisi ha ricadute dirette sulle modalità attraverso le quali valutare o misurare la QdV, come vedremo, e come anticipato da Gasper (2010) evidenzia diversi livelli di contrapposizione: la misurazione dello stato di benessere può focalizzarsi sia sullo stato soggettivo di una persona sia sulle reali condizioni e circostanze di vita; la misurazione può basarsi sui valori e sulle preferenze personali o su valori che scaturiscono da visioni pubbliche; i giudizi sulla Qualità della Vita, quindi la sua valutazione, può essere effettuata mediante *self-report* o tramite osservatori esterni.
L'orientamento soggettivo o oggettivo ha inoltre ovvie conseguenze sulla metodologia di analisi e valutazione della QdV, tanto dar luce alla contrapposizione di approcci qualitativi e di approcci quantitativi di ricerca, che approfondiremo in seguito. I primi tengono conto di variabili espresse in forma numerica, si basano su protocolli molto strutturati e questionari a risposte predefinite. Sono volti allo studio di ampi campioni d'indagine e assicurano la rappresentatività del campione. I secondi usano categorie associate a qualificazioni verbali ponendo l'enfasi sui processi, i significati e il vissuto esperienziale. Utilizzano tecniche di raccolta dati come l'intervista, il *focus group* e l'osservazione. In questo caso l'aspetto più importante non è la quantità o la significatività statistica ma la qualità e la profondità d'indagine sulla Qualità della Vita.

conoscere solamente il racconto soggettivo della propria vita non può, in considerazione degli inevitabili processi di adattamento, delle dinamiche psicologiche ricorrenti (il paradosso "il povero felice")[9] e delle limitazioni che implicano, darci informazioni scientificamente significative (Kahn e Juster, 2002).

Il quarto principio è l'estendibilità e la validità scientifica delle dimensioni della Qualità della Vita a tutte le persone. Le fonti internazionali sono unanimi nell'affermare, dagli anni 2000, che il costrutto della QdV debba essere applicabile a tutte le persone, ciò sta a significare che, a prescindere dalle caratteristiche della persona, la composizione degli aspetti della QdV è la stessa (*same components for all).* Autori come Wolfensberger (1994) e Cummins (1997) sottolineano le loro perplessità infatti nel definire la QdV come un insieme di dimensioni individuabili *ad hoc* per ogni gruppo di minoranza (*sub-populations),* come ad esempio le persone con disabilità. Il rischio concerne la selezione di uno standard di QdV per una sotto-popolazione che sarebbe non rappresentativo per la popolazione generale (Cummins, 1997), poiché molti gruppi di minoranza hanno un tenore di vita inferiore rispetto la popolazione generale. Cummins (2005a), in ragione di una maggiore equità, sostiene che vi è un insieme identificabile di dimensioni (*core building-blocks*) della QdV, che è comune a tutte le persone. L'utilizzo di queste dimensioni, dal punto di vista metodologico, permette di impiegare strumenti di valutazione con qualsiasi gruppo sociale senza distinzione di cultura, *status* socio-economico o condizione di disabilità. A tal proposito Brown, Hatton, ed Emerson (2013), quando parlano delle dimensioni della Qualità della Vita mettono in evidenza che devono rappresentare gli aspetti della vita che sono comuni a tutti gli esseri umani.

Il quinto principio concerne la variabilità inter e intrapersonale (*inter and intrapersonal variability*). Per variabilità gli autori intendono la diversa significatività e interpretazione che si attribuisce alle dimensioni della QdV. In altri termini, ogni persona attribuisce un valore o considera importante, o meno, un determinato ambito o aspetto della propria vita in base al proprio modello sociale e culturale di appartenenza (variabilità intrapersonale). Inoltre, la significatività e l'interpretazione sono dipendenti anche dalle caratteristiche personali, abitudini, credenze, valori e contesto di vita (variabilità interpersonale). Pertanto, ne consegue che "una buona qualità della vita" assuma significati diversi per persone diverse.

[9] A maggior ragione se si parla di persone con disabilità come vedremo.

Le dimensioni della Qualità della Vita risultano essere, in base alle concettualizzazioni che si adottano, le medesime per ogni soggetto ma variano significativamente in termini valoriali, d'importanza e di percezione (Giaconi, 2015, p. 27).

La variazione della composizione, o meglio, del "contenuto" (Giaconi, 2015, p.27) è da attribuire alla percezione individuale della propria condizione di vita, alle differenze culturali e sociali che indirettamente influenzano la QdV di una persona (Cummins, 2005a). La Qualità della Vita è definita in tal senso come "la misura in cui una persona in base al suo profilo di funzionamento, ai deficit, alle abilità e alle competenze, tenendo conto del contesto di vita, dei supporti e delle barriere in esso presenti, è in grado di soddisfare aspettative, desideri e bisogni *personalmente* significativi" (Fedeli, 2016, p.29).

È altresì da sottolineare che il "valore" attribuito ad domini di QdV dipenda dai contesti, esperienze e sistemi che influenzano la vita di ognuno (Schalock e Verdugo Alonso, 2002; Petry, Maes, Vlaskamp, 2009; Schalock, Keith, Verdugo Alonso, Gomez, 2010; Giaconi, 2015; Conner, 2015), sia soggetto alla percezione e alla rilevanza attribuita dal singolo e muti durante l'arco di vita (Schalock e Verdugo Alonso, 2006; Campo, Sharpton, Thompson, Sexton, 1997; Giaconi, 2015).

Il sesto principio fortemente connesso al precedente è la valenza di una prospettiva longitudinale della Qualità della Vita. Il valore attribuito dalla persona alle diverse dimensioni della QdV è connesso al periodo della vita e cambia nel corso di essa. Gli studiosi parlano di "*lifespain aspect of QOL*"(Brown & Brown, 2005) inteso come mutamento del costrutto della QdV durante l'arco di vita del soggetto.

"La Qualità della Vita, infatti, è sensibile alla dimensione spazio-temporale, poiché essa e la sua percezione cambiano potenzialmente sull'asse diacronico, nei diversi spazi e tempi della vita e, sull'asse sincronico, nei tempi e negli spazi attuali dell'esistenza della persona" (Giaconi, 2015, p.27).

La prospettiva longitudinale (*life-span perspective*) della QdV ne evidenzia la progettualità e l'intento di dare forma ad un progetto di vita personalizzato. Il paradigma della QdV è un approccio che vede il suo inizio con l'inizio della vita della persona, con o senza disabilità, e si conclude con essa in una logica sistemica finalizzata a valorizzare le opportunità della persona, all'autodeterminazione e alla vita indipendente.

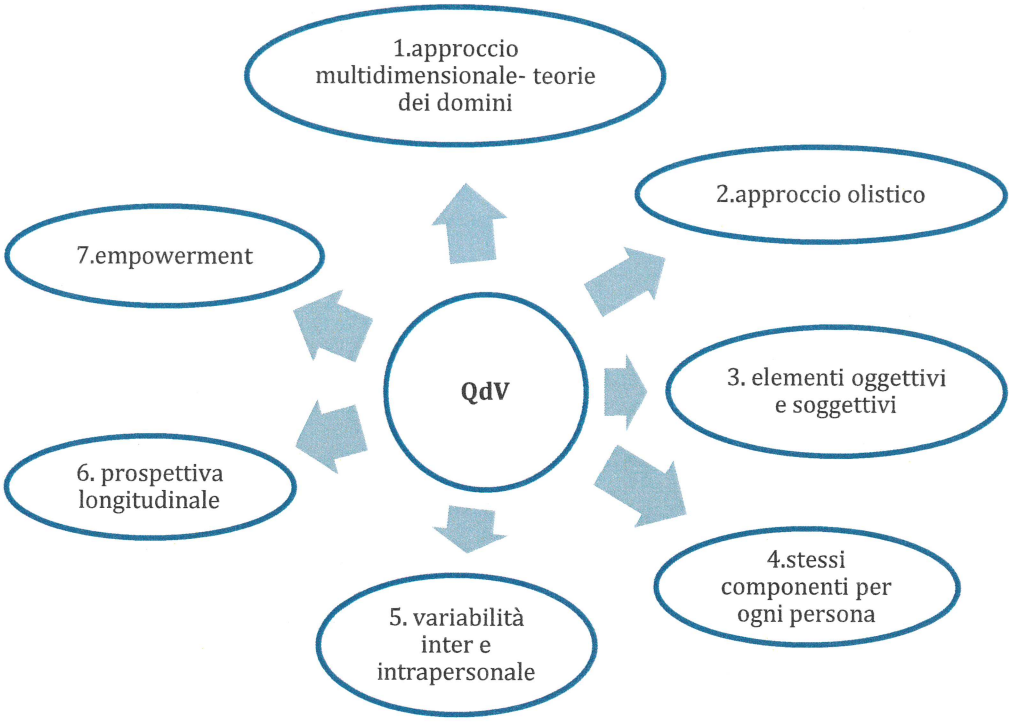


Fig. 1 I principi della Qualità della Vita

Il settimo principio è stato enucleato in questi termini "immagine di sé, valori, scelte, controllo personale ed *empowerment*" (Conner, 2013). Secondo noi è possibile sintetizzarlo nel concetto di *empowerment*, poichè la QdV può essere letta come un costrutto che emancipa la persona (empowerment), a partire dalla propria espressione personale, dall'accettazione e la consapevolezza delle scelte e dal riconoscimento dei propri valori, in una prospettiva di continuo miglioramento delle condizioni di vita e di crescita personale.

Possiamo mettere in luce gli scopi del paradigma della Qualità della Vita. Le ragioni che hanno spinto i ricercatori a cercare un costrutto sociale, un concetto sensibilizzante e un tema unificante (Schalock, Brown, Brown, Cummins, et al., 2002) come quello della Qualità della Vita sono plurime. La prima è la netta convinzione che i progressi scientifici, medici e tecnologici dovrebbero tradursi come un migliore stato di benessere generale per tutti i cittadini del pianeta e per

farlo è necessario indagare aspetti e dinamiche personali, familiari, comunitari; nella certezza che la società del benessere possa emergere solo da complesse combinazioni tra i progressi scientifici e i valori, le percezioni e le condizioni ambientali personali. La seconda ragione è l'aumento negli ultimi anni del potere dei consumatori dei servizi, i quali sono intenzionati ad analizzare e comprendere cosa e come effettivamente migliorare la loro condizione di vita. Questo fenomeno è il risultato dei movimenti per i diritti civili, l'enfasi sulla pianificazione di servizi centrati sulla persona, il concetto di autodeterminazione e la volontà di essere attori sociali attivi e consapevoli. Il terzo motivo è che i processi e le pratiche di inclusione hanno portato a riflettere non solo sulla gestione e l'organizzazione dei servizi alla persona nella comunità, ma anche sulla prospettiva della persona disabile presa come fonte di valutazione dei servizi offerti dalla comunità.

Il paradigma della Qualità della Vita vede la sua più completa realizzazione se si pone come criterio di orientamento delle pratiche educative e delle politiche sociali. È un approccio che vede il suo inizio con l'inizio della vita della persona e si conclude con essa in una logica sistemica finalizzata a valorizzare le opportunità della persona, l'autodeterminazione e la vita indipendente. È un costrutto che vede la sua applicazione nelle politiche pubbliche e nei servizi alla persona chiamati a: valutare i livelli di QdV, attuare interventi mirati al potenziamento dei livelli di QdV e monitorare nel tempo i processi in una logica progettuale di perenne di miglioramento.

In conclusione, lo scopo ultimo di qualsiasi intervento orientato alla Qualità della Vita deve essere quello di migliorare l'immagine di sé della persona e fornire ambienti potenzianti che aumentino le opportunità del soggetto di controllare gli aspetti della sua vita che sono a loro volta influenzati dai valori della persona. La QdV tuttavia si riferisce alle scelte compiute dalle persone e, ove possibile, al controllo personale sui propri interessi, attività, interventi e ambienti di vita. La QdV per tali ragioni può essere letta come un costrutto che emancipa la persona (empowerment), a partire dalla propria espressione personale, dall'accettazione e la consapevolezza delle scelte e dal riconoscimento dei propri valori fino a giungere al controllo che la persona esercita sul suo ambiente di vita ("porre al centro la persona").